KARLYON ENTERPRISE S.A.

(Soluções Académicas e Empresariais Aplicadas)

Entidade Formadora: ENCORP • Curso de CPD (Desenvolvimento Profissional Contínuo)

Estabilização de pacientes

Acesso venoso e fluidos

Aula 3 de 6 · 1 hora

Coordenador: Sacaita Manuel Inácio

Formação não qualificante, de carácter habilitante

Acesso venoso e fluidos

No final desta aula o formando deve ser capaz de:

Escolha de cateter, cuidados e administração de fluidos.

O acesso venoso periférico permite medicamentos e fluidos. A técnica asséptica e a vigilância previnem complicações. Nesta aula aprende a escolher o cateter e o local, a técnica passo a passo, os tipos de fluidos e como vigiar complicações.

Roteiro

1. O que vai aprender nesta aula
2. Quando é preciso um acesso venoso
3. Escolher o cateter
4. Escolher o local
5. Técnica passo a passo
6. Tipos de fluidos
7. Administrar com segurança
8. Caso clínico: homem de 30 anos com diarreia
9. Caso clínico: resolução
10. Vigilância e complicações
11. Erros frequentes
12. Pontos-chave
13. Para reflectir
14. Para aprofundar

O que vai aprender nesta aula

No final desta aula será capaz de:

1. Indicar quando é necessário um acesso venoso periférico
2. Escolher o calibre do cateter e o local de punção
3. Descrever a técnica asséptica, passo a passo
4. Distinguir os tipos de fluidos e calcular o ritmo de gotejamento
5. Reconhecer e tratar as complicações mais comuns

Quando é preciso um acesso venoso

- Administrar medicamentos por via endovenosa
- Repor fluidos (desidratação, hemorragia, choque)
- Administrar hemoderivados
- Garantir uma via segura em doentes graves ou com risco de agravamento
- Em choque ou hemorragia: **dois acessos** de calibre largo

> O acesso venoso central é uma decisão e uma técnica médicas. Em emergência, o acesso periférico é o primeiro passo.

Escolher o cateter

Calibre	Cor	Fluxo aproximado	Uso habitual
14 G	Laranja	240 mL/min	Trauma, hemorragia grave
16 G	Cinzento	180 mL/min	Choque, cirurgia
18 G	Verde	90 mL/min	Fluidos, transfusão
20 G	Rosa	60 mL/min	Uso geral no adulto
22 G	Azul	35 mL/min	Idosos, veias frágeis, crianças
24 G	Amarelo	20 mL/min	Recém-nascidos, veias muito finas

Valores aproximados: variam com o fabricante. Use o **menor calibre** que serve a necessidade.

Escolher o local

- Prefira as veias do **antebraço** e do dorso da mão, começando pela zona mais distal
- Procure uma veia macia, elástica e recta; evite veias duras ou tortuosas
- Evite a dobra do cotovelo, se houver alternativa, porque o movimento dobra o cateter
- Evite: membro com fístula arteriovenosa, braço do lado de mastectomia ou linfedema, membro paralisado, pele lesada ou infectada
- Nos adultos, evite os membros inferiores (risco de trombose)

Técnica passo a passo

Preparar

material à mão e higiene das mãos, luvas

Garrote

cerca de 10 cm acima do local, e escolher a veia

Desinfectar

pele com antisséptico e esperar que seque

Puncionar

bisel para cima, ângulo de 10 a 30°, até ver sangue

Avançar

introduza o cateter, retire a agulha, solte o garrote

Fixar

cobertura estéril, lavar com soro, identificar a data

Tipos de fluidos

Tipo	Exemplos	Uso principal
Cristaloides isotónicos	Soro fisiológico 0,9%, Ringer lactato	Reposição de volume
Soluções glicosadas	Glicose 5%	Fornece água e energia; não repõe volume
Hemoderivados	Concentrado de eritrócitos	Hemorragia grave, por prescrição

A escolha do fluido, do volume e do ritmo é uma **prescrição**. Ao enfermeiro cabe administrar com segurança, vigiar e comunicar.

Administrar com segurança

- Confirme: doente, fluido, volume, ritmo, via e prazo de validade
- Em hipovolemia: bólus prescritos (por exemplo, 250 a 500 mL no adulto) com **reavaliação depois de cada bólus**
- Cálculo do gotejamento: **gotas/min = volume (mL) × factor de gotas ÷ tempo (min)**

> **Exemplo:** 1000 mL em 8 horas, com equipo de 20 gotas/mL: 1000 × 20 ÷ 480 = cerca de **42 gotas por minuto**.

Caso clínico: homem de 30 anos com diarreia

Homem de 30 anos, com diarreia e vómitos há 3 dias, muito fraco.

- Mucosas secas, olhos encovados
- Pulso: 128 por minuto; tensão arterial: 85/50 mmHg
- Enchimento capilar: 4 segundos

Pense antes de avançar: que tipo de acesso e de fluido? Como saberá se está a melhorar?

Caso clínico: resolução

- Sinais de **choque hipovolémico** por desidratação
- Dois acessos periféricos, de calibre 18 G ou maior
- Cristaloide em **bólus prescritos**, com reavaliação depois de cada um
- Melhoria esperada: pulso a descer, tensão a subir, enchimento capilar mais rápido, diurese
- Vigie sinais de sobrecarga: dificuldade em respirar, crepitações, edemas
- Colha sangue (ionograma, glicemia) e procure a causa

Vigilância e complicações

Complicação	Sinais	O que fazer
Infiltração	Inchaço, frio, dor, fluxo lento	Parar, retirar o cateter, elevar o membro
Flebite	Vermelhidão, calor, cordão doloroso	Retirar o cateter e avisar
Infecção local	Pus, febre	Retirar, avisar, colheitas segundo protocolo
Hematoma	Tumefacção depois da punção	Compressão e novo local
Sobrecarga de fluidos	Dispneia, edemas, crepitações	Reduzir ou parar, sentar o doente, avisar

Erros frequentes

- Falhar a higiene das mãos
- Tocar na pele depois de a desinfectar
- Não confirmar o retorno venoso e a permeabilidade antes de infundir
- Não datar o penso nem avaliar o local em cada turno
- Manter o cateter sem indicação
- Ignorar a dor referida pelo doente

Pontos-chave

1. Use o menor calibre que serve a necessidade
2. Técnica asséptica: higiene das mãos e antisséptico seco
3. Em choque: dois acessos de calibre largo
4. Fluidos são prescrição; reavalie depois de cada bólus
5. Gotas/min = volume × factor ÷ tempo
6. Vigie o local de punção em todos os turnos

Para reflectir

Discuta com um colega ou com o seu orientador:

? Quais são os obstáculos reais à técnica asséptica no seu serviço?

? Como explicaria a um doente porque é preciso retirar um cateter que ainda funciona?

? Que sinais o fariam parar uma infusão?

Para aprofundar

Consulte no ENCORP:

→ Água destilada e soro fisiológico 0,9%

→ Clorexidina 0,5%

→ Álcool etílico 70%

PRÓXIMO PASSO

Teste de avaliação

- 10 perguntas de escolha múltipla
- Nota mínima de aprovação: 70%
- Reveja os pontos-chave antes de começar
- Pode repetir o teste as vezes que quiser